

रेक्टोयूरेथ्रल फिस्टुला (पुरुषों में)

रोगी जानकारी • मलाशय और मूत्रमार्ग के बीच एक असामान्य संबंध

WARWIKI

रेक्टोयूरेथ्रल फिस्टुला मलाशय (पिछला मार्ग) और मूत्रमार्ग (पेशाब की नली) के बीच एक असामान्य संबंध (छोटी सुरंग) होता है। इससे पेशाब मलाशय में और गैस या मल पेशाब में जा सकता है, जिससे बार-बार संक्रमण होता है। यह कष्टदायक है, लेकिन ठीक किया जा सकता है — आमतौर पर चरणबद्ध तरीके से।

इस स्थिति के बारे में

लक्षणों में अक्सर **पेशाब में गैस या मल** (पेशाब करते समय बुलबुले, धुंधला या बदबूदार पेशाब), **मलाशय से पेशाब का रिसाव**, बार-बार UTI, और पेल्विक असुविधा शामिल हैं। यह एक नलसाजी समस्या है जिसका नलसाजी समाधान है — आपकी किसी गलती का नतीजा नहीं।

कारण

अधिकांश फिस्टुला **प्रोस्टेट कैंसर उपचार की जटिलता** हैं — सर्जरी (prostatectomy), **radiation**, या ablation (जैसे cryotherapy या HIFU) — या मलाशय की सर्जरी के बाद। कम मामलों में चोट, संक्रमण, या inflammatory bowel disease से होते हैं। **Radiation** के बाद के फिस्टुला ठीक होने में अधिक जटिल होते हैं।

शब्दों को समझें

फिस्टुला

दो अंगों को जोड़ने वाली असामान्य सुरंग।

रेक्टोयूरेथ्रल

मलाशय और मूत्रमार्ग के बीच।

Pneumaturia

पेशाब में गैस/बुलबुले।

Fecaluria

पेशाब में मल का आना।

Diversion

ठीक होने के लिए पेशाब और/या मल को अस्थायी रूप से मोड़ना।

Colostomy

अस्थायी मल-निकास, जिसे बाद में बंद किया जा सकता है।

Gracilis flap

मरम्मत को मज़बूत करने के लिए जाँघ की मांसपेशी का उपयोग।

मुझे पहले अस्थायी stoma या catheter की ज़रूरत क्यों हो सकती है? पेशाब (catheter या tube से) और कभी-कभी मल (अस्थायी colostomy से) को मोड़ने से उस क्षेत्र पर दबाव कम होता है, संक्रमण नियंत्रित होता है, और सूजे हुए ऊतक को ठीक होने का समय मिलता है — जिससे बाद की मरम्मत के सफल होने की संभावना बढ़ती है। ये diversion आमतौर पर **अस्थायी** होते हैं और ठीक होने के बाद बंद कर दिए जाते हैं।

जाँच कैसे होती है

- मूत्राशय/मूत्रमार्ग (**cystoscopy**) और मलाशय का अंदर से देखना
- फिस्टुला का आकार और स्थान जानने के लिए **dye test** और imaging
- आपके इतिहास (प्रोस्टेट उपचार, radiation) और ऊतक की गुणवत्ता की समीक्षा

इलाज कैसे होता है

- 1 **आराम और diversion** — लक्षण नियंत्रित करने और ऊतक ठीक होने के लिए catheter (और कभी-कभी अस्थायी colostomy)।
- 2 **सर्जिकल मरम्मत** — अक्सर अंडकोष और गुदा के बीच से (transperineal), संबंध को परतों में बंद करना।
- 3 **Tissue flap** — स्वस्थ मांसपेशी (अक्सर **gracilis** जाँघ flap) को मरम्मत के बीच रखा जाता है, खासकर radiation के बाद।
- 4 **Reversal** — ठीक होने की पुष्टि के बाद अस्थायी stoma बंद किए जाते हैं।

ज़रूरी बातें

- समय महत्वपूर्ण है — सर्जन अक्सर मरम्मत से पहले सूजन कम होने का इंतज़ार करते हैं।
- छोटे, non-radiated फिस्टुला कभी-कभी केवल catheter से बंद हो जाते हैं।
- अच्छा पोषण और धूम्रपान न करना ठीक होने में मदद करता है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार, ठंड लगना, या बहुत अस्वस्थ महसूस करना (गंभीर संक्रमण हो सकता है)
- तेज़ pelvic या मलाशय दर्द
- पेशाब न आना, या अत्यधिक रक्तस्राव

याद रखने योग्य तीन बातें

1. रेक्टोयूरेथ्रल फिस्टुला मलाशय और मूत्रमार्ग को जोड़ता है — जिससे पेशाब में गैस/मल और संक्रमण होता है — अक्सर प्रोस्टेट कैंसर उपचार के बाद।
2. उपचार चरणबद्ध होता है: पहले diversion और आराम, फिर मरम्मत (अक्सर tissue flap के साथ, खासकर radiation के बाद), फिर अस्थायी stoma बंद।
3. यह ठीक हो सकता है। बुखार, तेज़ दर्द, या पेशाब न आने पर तुरंत चिकित्सा लें।